

Question 63 : Schizophrénie

1) Selon le DSM 5, la schizophrénie est définie par :

- A- La symptomatologie doit comprendre des idées délirantes et un comportement désorganisé coexistant pendant au moins un mois
- B- Une durée d'évolution des symptômes d'au moins six mois
- C- Un dysfonctionnement social ou des activités
- D- Des symptômes de dissociation
- E- Les symptômes négatifs sont obligatoires pour le diagnostic

Réponse : **BC**

2) La schizophrénie :

- A- Il s'agit d'un trouble psychotique caractérisé par des perturbations profondes de la pensée, des émotions, des perceptions et du comportement
- B- Ses modalités évolutives sont variables d'un patient à l'autre
- C- Son évolution chronique comporte une phase résiduelle où le trouble n'est jamais en rémission
- D- Elle est rarement associée des déficits neurocognitifs
- E- Son expression clinique est constante dans le temps

Réponse : **AB**

3) Concernant la schizophrénie :

- A- Son étiologie est multifactorielle
- B- Elle est la plus fréquente des psychoses aiguës
- C- Ses symptômes relèvent de 3 dimensions principales : positive, négative et résiduelle
- D- L'âge de début se situe souvent à l'adolescence, ou après 35 ans
- E- Selon l'OMS elle est parmi les dix maladies qui entraînent le plus d'invalidité en particulier chez le sujet adulte

Réponse : **A**

4) La bouffée délirante aiguë :

- A- Il s'agit de l'un des modes de début aigu de la schizophrénie
- B- Elle correspond au trouble psychotique bref ou trouble schizophréniforme selon le DSM
- C- Elle peut représenter un diagnostic différentiel avec une confusion mentale
- D- Elle est souvent associée à des fluctuations thymiques et à une angoisse importante
- E- Elle évolue dans la moitié des cas vers la schizophrénie

Réponse : **ABCD**

5) La phase prémorbide de la schizophrénie :

- A- Elle précède d'environ cinq ans l'entrée dans la schizophrénie
- B- C'est la première phase de l'évolution chronique de la schizophrénie
- C- On peut y retrouver de troubles de la coordination motrice ou des troubles mnésiques
- D- Elle peut comporter des symptômes psychiatriques spécifiques comme les troubles anxieux
- E- Les troubles des interactions sociales peuvent être rencontrés

Réponse : **BCE**

6) La phase prodromale de la schizophrénie :

- A- Cette phase correspond à l'enfance des futurs patients atteints de schizophrénie
- B- Sa phase précoce est marquée des symptômes peu spécifiques
- C- Des signes neurologiques mineurs peuvent être observés
- D- Sa phase tardive est caractérisée par des symptômes psychotiques négatifs
- E- Sa phase tardive est caractérisée par des symptômes psychotiques positifs atténués ou de signes positifs intenses, fugaces, qui dure au maximum un mois

Réponse : **B**

7) Parmi ces éléments, lesquels constituent des facteurs de mauvais pronostic lors d'une bouffée délirante aiguë :

- A- Absence d'antécédents familiaux de schizophrénie
- B- Le mauvais fonctionnement social et professionnel pré morbide
- C- Personnalité pré morbide de type schizoïde
- D- La critique imparfaite du délire
- E- La richesse du délire

Réponse : **BCD**

8) Parmi ces éléments, lesquels constituent des facteurs de bon pronostic lors d'une bouffée délirante aiguë :

- A- L'installation progressive, en plus d'un mois (début non brutal)
- B- L'existence d'éléments confusionnels à l'acmé de l'épisode psychotique
- C- L'absence d'une note thymique associée
- D- L'existence d'un émoussement affectif
- E- La bonne réponse au traitement antipsychotique

Réponse : **BE**

9) Parmi les modes d'entrée brutale dans la schizophrénie, on retrouve :

- A- Des troubles des conduites
- B- Des comportements impulsifs et bizarres
- C- Des actes médicolégaux prémédités
- D- Des phobies suspectes
- E- Un état confusionnel

Réponse : **BE**

10) Lors d'une dépression atypique, on retrouve :

- A- Une perte d'intérêt
- B- Un ralentissement psychomoteur
- C- Un détachement marqué
- D- Un repli plus que de la tristesse
- E- Une hyperphagie

Réponse : **ABCD**

11) Un début aigu d'une schizophrénie peut se faire par :

- A- Un épisode psychotique bref
- B- Un épisode dépressif caractérisé avec caractéristiques atypiques
- C- Une manie atypique
- D- Un voyage pathologique
- E- Une tentative de suicide

Réponse : **ACDE**

12) Le début progressif de la schizophrénie peut se faire par :

- A- Des obsessions avec une forte lutte anxieuse
- B- Des phobies sans véritable recherche d'une réassurance
- C- Des situations phobogènes multiples et sans lien entre elles
- D- Des plaintes hypocondriaques touchant surtout l'apparence ou l'identité du corps
- E- L'évitement des situations phobogènes est quasi systématique

Réponse : **BCD**

13) Dans la manie atypique :

- A- C'est un état d'excitation psychique
- B- Peut constituer un mode de début progressif de la schizophrénie
- C- L'euphorie est au premier plan
- D- La tachypsychie s'organise de façon incohérente par assonance ou par contiguïté
- E- L'agitation peut avoir un aspect bizarre

Réponse : **AE**

14) Dans la schizophrénie :

- A- La modification du caractère est une caractéristique de la phase d'état
- B- La conviction du sujet vis à vis du vécu délirant est très fluctuante au début
- C- Des croyances à des phénomènes surnaturels sont fréquentes
- D- Les tests psychométriques sont très utiles pour le diagnostic à la phase d'état chez le schizophrène
- E- Le diagnostic de schizophrénie peut reposer sur la modification du caractère et l'altération des performances cognitives

Réponse : **BC**

15) L'idée délirante :

- A- Peut être partagée par le groupe socioculturel
- B- Le sujet est conscient de son caractère morbide
- C- Elle est accessible à la contestation par les faits
- D- Est sous-tendue par un trouble affectif
- E- Elle est caractérisée par un thème, un mécanisme, un degré de systématisation, un degré de cohérence et une durée

Réponse : **D**

16) Le début progressif de la schizophrénie peut se faire par :

- A- Une polytoxicomanie d'apparition tardive
- B- Une anorexie mentale associée à une hyperactivité
- C- Des conduites de délinquance conformes avec l'organisation antérieure de la personnalité
- D- Un délire
- E- Une altération des performances cognitives

Réponse : **DE**

17) La dysmorphophobie :

- A- Elle se définit par une crainte obsédante d'être atteint d'une transformation d'une partie du corps
- B- Elle ne peut pas inaugurer la schizophrénie
- C- L'identité sexuelle est souvent au centre de ces préoccupations
- D- Le visage est rarement l'objet d'une dysmorphophobie
- E- Elle se voit exclusivement lors de la schizophrénie

Réponse : **AC**

18) Le thème délirant dans la schizophrénie :

- A- Il correspond au sujet principal sur lequel porte l'idée délirante
- B- Il correspond au processus par lequel l'idée délirante s'établit
- C- La culpabilité représente le thème le plus fréquent
- D- Dans la schizophrénie, les thèmes sont habituellement multiples et hétérogènes
- E- Le thème de mégalomanie est toujours associé à un mécanisme hallucinatoire

Réponse : **AD**

19) Le délire à développement insidieux chez le schizophrène :

- A- Il est fréquemment associé à dépersonnalisation et de la déréalisation
- B- Le mécanisme hallucinatoire visuel est le plus fréquent
- C- Il est rapidement repéré par l'entourage
- D- Il peut rester isolé
- E- Les thèmes délirants sont multiples

Réponse : **ADE**

20) Le mécanisme du délire :

- A- C'est le mode d'élaboration et d'organisation de l'idée délirante
- B- Quatre types de mécanisme existent : hallucinatoire, interprétatif, imaginatif et psychosensoriel
- C- Le mécanisme hallucinatoire est le mécanisme le plus fréquent dans la schizophrénie
- D- Contrairement aux hallucinations psychosensorielles, celles psychiques ne sont pas caractérisées par la sensorialité et la spacialité
- E- Les hallucinations cénesthésiques désignent des images mentales ou des représentations idéiques

Réponse : **ACD**

21) L'automatisme mental :

- A- Il est défini comme une perception sans objet à percevoir
- B- Il s'agit d'hallucinations relevant de manifestations sensorielles
- C- C'est le sentiment d'être dépossédé de sa vie intérieure et d'être entièrement dirigé de l'extérieur
- D- C'est le fait de ne plus être sûr de rester maître de soi même
- E- Il comporte des phénomènes psychiques et moteurs qui s'imposent à la conscience du sujet, malgré lui et de façon presque mécanique

Réponse : **DE**

22) Dans la schizophrénie :

- A- Le délire paranoïde est un délire non systématisé, flou, sans logique
- B- Le délire paranoïde a une cohérence qui donne une certaine logique à la production délirante
- C- L'adhésion au délire peut être variable
- D- Le délire est responsable d'un retentissement émotionnel et comportemental
- E- La dangerosité, conséquence de la désorganisation, doit toujours être évaluée

Réponse : **ACD**

23) Face à un patient schizophrène, il faut évaluer systématiquement :

- A- Le niveau d'anxiété
- B- Les capacités d'abstraction
- C- Le risque suicidaire
- D- La réponse aux médicaments antérieurement prescrits
- E- Le risque de passage à l'acte hétéro-agressif

Réponse : **ACDE**

24) Les signes négatifs de la schizophrénie sont caractérisés par :

- A- Des affects émoussés
- B- Alogie
- C- Indifférence
- D- Discordance idéo-affective
- E- Illogisme

Réponse : **ABC**

25) La phase d'état de la schizophrénie :

- A- Elle se caractérise par un délire, des signes négatifs et des symptômes de désorganisation
- B- Les symptômes négatifs touchent les trois sphères : intellectuelle, affective et le langage
- C- L'altération des fonctions cognitives est constante
- D- La désorganisation traduit l'appauvrissement de la vie psychique
- E- L'incohérence entre le discours et les émotions exprimées est très évocatrice

Réponse : **AE**

26) Les signes négatifs de la schizophrénie :

- A- Ils correspondent à la perte de l'unité psychique entre pensées, affectivité et attitudes
- B- Ils sont responsables de l'absence d'émotions dans l'expression du visage et dans l'intonation de la voix
- C- Les barrages et le fading sont parmi les signes négatifs les plus fréquents
- D- L'apragmatisme et l'aboulie font partie des signes négatifs au niveau comportemental
- E- Ils peuvent entraîner un retrait social

Réponse : **BDE**

27) À propos les atteintes cognitives lors de la schizophrénie :

- A- L'alogie est un signe désorganisation schizophrénique
- B- L'illogisme se traduit par un discours diffluent, et des propos décousus
- C- Les capacités d'abstraction sont altérées
- D- Les paralogismes sont une symptomatologie touchant le langage traduisant la désorganisation au niveau cognitif
- E- Le rationalisme morbide s'appuie sur des intuitions, des mélanges d'idées, des analogies

Réponse : **CD**

28) La désorganisation comportementale dans la schizophrénie peut se traduire par :

- A- Une discordance idéo-affective
- B- Un maniérisme gestuel
- C- Des parakinésies
- D- Un syndrome catatonique fait d'une cataplexie, un négativisme et des stéréotypies
- E- Une écholalie ou une échopraxie peuvent se rencontrer

Réponse : **BCE**

29) À propos les altérations des fonctions cognitives dans la schizophrénie :

- A- Elles sont fréquentes et souvent bénignes
- B- Elles précèdent souvent le début de la maladie
- C- Elles fluctuent avec l'évolution de la maladie
- D- La mémoire implicite est préservée
- E- Les fonctions exécutives, la mémoire épisodique, l'attention et la vitesse de traitement de l'information sont parmi les plus altérés

Réponse : **BDE**

30) Lors de la schizophrénie :

- A- La désorganisation comportementale est associée à un fort retentissement fonctionnel
- B- Le délire présente un retentissement émotionnel et cognitif
- C- L'aboulie et l'apragmatisme peuvent entraîner une vie relationnelle pauvre et une perte de l'intérêt social
- D- Le dysfonctionnement social est obligatoire pour le diagnostic selon le DSM 5
- E- Les altérations cognitives sont à l'origine d'un handicap psychique important

Réponse : **CDE**

31) Un arrêt brusque dans le déroulement et l'énonciation de la pensée s'appelle :

- A- Une aboulie
- B- Une amnésie sélective
- C- Un coq à l'âne
- D- Un barrage
- E- Un maniérisme verbal

Réponse : **D**

32) Dans la schizophrénie selon le DSM 5 :

- A- Un trouble schizo-affectif doit être exclu
- B- En cas d'antécédents d'un trouble du spectre autistique, le diagnostic de schizophrénie n'est fait que si les idées délirantes ou les hallucinations sont légers et sont présentes avec les autres symptômes requis pour le diagnostic pendant au moins 2 mois
- C- Seul le sous-type paranoïde est préservé
- D- La symptomatologie peut être expliquée par une affection médicale
- E- La présence d'idées délirantes et/ou hallucinations et/ou discours désorganisé pendant au moins un mois est obligatoire pour le diagnostic

Réponse : **AE**

33) Parmi ces situations cliniques, lesquelles peuvent constituer un diagnostic différentiel de la schizophrénie :

- A- L'insuffisance hypophysaire
- B- Maladie de Cushing
- C- États psychotiques post-traumatiques
- D- Tumeurs cérébrales occipitales
- E- Lupus érythémateux systémique

Réponse : **ACE**

34) Parmi les éléments suivants, lesquels orientent beaucoup plus vers le diagnostic d'épilepsie que vers une schizophrénie :

- A- Le caractère paroxystique des hallucinations et/ou des idées délirantes
- B- La thématique délirante est généralement bien élaborée
- C- Des signes somatiques comme les troubles du transit ou du rythme cardiaque sont souvent associés
- D- Les affects sont assez préservés
- E- Prédominance des symptômes négatifs

Réponse : AD

35) Parmi ces situations cliniques, lesquelles peuvent constituer un diagnostic différentiel de la schizophrénie :

- A- Maladie d'Addison
- B- Maladie de Parkinson
- C- Sclérose en plaque
- D- Phéochromocytome
- E- Manifestations psychotiques suite à un alcoolisme chronique

Réponse : AE

36) Parmi les substances suivantes, lesquelles peuvent donner un tableau clinique pouvant constituer un diagnostic différentiel avec la schizophrénie :

- A- Le cannabis
- B- Les drogues psychoanaleptiques
- C- Les corticoïdes
- D- La bromocriptine
- E- Les antiparkinsoniens

Réponse : ACDE

37) Parmi ces situations cliniques, lesquelles peuvent constituer un diagnostic différentiel de la schizophrénie :

- A- La consommation de LSD
- B- Un trouble schizo-affectif
- C- Un épisode manique avec caractéristiques psychotiques
- D- Une personnalité schizotypique
- E- Une personnalité schizoïde

Réponse : ABD

38) Concernant le trouble délirant :

- A- Le délire est flou
- B- L'âge de début est plus tardif que dans la schizophrénie
- C- Absence de désorganisation
- D- Le type mixte constitue à diagnostic différentiel avec la schizophrénie
- E- Absence d'hallucinations

Réponse : BCE

39) Parmi les éléments suivants lesquels orientent vers le diagnostic de schizophrénie :

- A- L'évolution est caractérisée par des intervalles libres entre les épisodes et les manifestations psychotiques apparaissent exclusivement en association avec les symptômes thymiques
- B- Les décompensations dépressives sont fréquentes mais sont surajoutées aux troubles psychotiques
- C- Les symptômes psychotiques persistent durant les intervalles séparant les phases actives de la maladie même après disparition des symptômes thymiques
- D- Présence de symptômes anxieux ou hystériques avec de symptômes psychotiques à minima
- E- Le délire est systématisé avec une cohérence donnant une certaine logique à la production délirante

Réponse : BD

40) Concernant la schizophrénie :

- A- Son évolution est très variable d'un sujet à l'autre
- B- Une guérison totale est rare
- C- L'évolution déficitaire est rare
- D- L'évolution est caractérisée par la survenue de poussées aiguës sur un fond de symptômes résiduels
- E- Après chaque rechute, le patient retrouve son niveau fonctionnel initial

Réponse : **ABCD**

41) Les facteurs de bon pronostic de la schizophrénie :

- A- Sexe masculin
- B- Environnement favorable
- C- Début précoce
- D- Bon insight
- E- Bon fonctionnement pré-morbide

Réponse : **BDE**

42) La schizophrénie peut se compliquer par :

- A- Suicide
- B- Comorbidité somatique élevée
- C- Conduites d'évitement
- D- Conduites addictives
- E- Mauvaise insertion socio-professionnelle

Réponse : **ABDE**

43) Concernant l'évolution de la schizophrénie :

- A- Plus la durée de psychose non traitée est courte, plus elle constitue un facteur de bon pronostic
- B- La schizophrénie résistante est définie par la non-réponse à 2 antipsychotiques à dose adéquate pendant une durée de 4 à 8 semaines
- C- La durée de psychose non traitée est définie par la période qui s'étend de l'apparition des premières manifestations non spécifiques jusqu'au début de la prise en charge
- D- La mortalité des schizophrènes est plus élevée que celle de la population générale
- E- Le suicide est moins fréquent chez les schizophrènes que dans la population générale

Réponse : **AD**

44) La schizophrénie :

- A- Débute classiquement chez l'adulte jeune
- B- Peut se compliquer d'épisodes dépressifs
- C- Nécessite le plus souvent une neuroleptisation au long cours
- D- Ne majore pas le risque suicidaire
- E- Laisse prédire un risque d'incapacité de resocialisation

Réponse : **ABCE**

45) Parmi les signes cliniques suivants, lequel est le plus évocateur d'une schizophrénie :

- A- Délire
- B- Hallucination
- C- Discordance
- D- Trouble mnésique
- E- Confusion mentale

Réponse : **C**

46) Parmi les symptômes suivants lesquels peuvent se voir lors d'une catatonie :

- A- Flexibilité cireuse
- B- Impulsions
- C- Logorrhée
- D- Maintien des attitudes imposées
- E- Refus de s'alimenter

Réponse : **ABDE**

47) Parmi les signes cliniques, indiquez lequel (ou lesquels) est (sont) rencontré(s) dans la schizophrénie :

- A- Expérience délirante d'étrangeté
- B- Syndrome de dépersonnalisation
- C- Thèmes délirants d'influence
- D- Affectivité inadaptée, paradoxale
- E- Actes impulsifs

Réponse : ABCDE

48) Devant un tableau délirant évoluant depuis plusieurs années, quel est ou quels sont les éléments qui oriente(nt) vers un diagnostic de schizophrénie :

- A- Début avant 30 ans
- B- Passage à l'acte étrange sans motivation apparente
- C- Syndrome d'influence
- D- Cohérence du délire
- E- Prédominance des éléments thymiques

Réponse : ABC

49) Devant un premier épisode d'allure maniaque, quels sont les éléments qui orientent vers la schizophrénie :

- A- L'excitation est plus psychique que thymique
- B- Le contact est ludique
- C- La tachypsychie se fait par assonance ou par contiguïté
- D- L'agitation est accompagnée par de la bizarrerie
- E- L'euphorie est absente ou au second plan

Réponse : ADE

50) Parmi les signes cliniques suivants, quels sont ceux qui doivent évoquer un début de schizophrénie chez une femme de 30 ans :

- A- Début des troubles lors du post-partum
- B- Association au tableau d'une insomnie mixte
- C- Existence d'obsessions bizarres
- D- Froideur du contact
- E- Méconnaissance de l'état morbide

Réponse : CDE

51) Les antipsychotiques ont une action sur :

- A- L'agitation
- B- Les signes négatifs
- C- La tristesse
- D- Les perturbations de la pensée
- E- Le délire

Réponse : ABDE

52) Le choix de l'antipsychotique est motivé par :

- A- Son profil d'action
- B- Sa demi vie
- C- La voie d'administration requise
- D- Réponse préalable du patient au médicament
- E- Ses effets indésirables

Réponse : ACDE

53) Concernant les principes généraux du traitement de la schizophrénie :

- A- On opte pour la molécule la mieux tolérée possible
- B- On prescrit à la plus forte dose efficace possible afin de prévenir les rechutes
- C- On maintient l'antipsychotique pendant 2-5 ans après un 1^{er} épisode de schizophrénie
- D- On prescrit systématiquement un correcteur anti-cholinergique afin de prévenir les effets secondaires des antipsychotiques
- E- On recourt aux antipsychotiques en 2^{ème} intention, en cas d'échec des mesures psychothérapeutiques

Réponse : **AC**

54) Les antipsychotiques :

- A- Leur dénominateur commun est l'antagonisme des récepteurs D1
- B- L'effet antidéficitaire est plus marqué avec les neuroleptiques
- C- L'amisulpride possède une action désinhibitrice à partir de 400 mg/j
- D- Les molécules sédatives sont à utiliser en aigu mais à limiter par la suite
- E- L'effet incisif est en général plus tardif que le sédatif

Réponse : **DE**

55) Concernant les principes généraux du traitement de la schizophrénie :

- A- Les antipsychotiques classiques sont recommandés de première intention
- B- Les antipsychotiques à action prolongée peuvent être envisagés comme traitement de 1^{ère} ligne
- C- Une réponse insuffisante après 6 semaines d'antipsychotiques impose une modification de posologie ou un changement de molécule
- D- Le seul critère à prendre en compte pour choisir la dose du traitement est les effets secondaires
- E- L'association de deux antipsychotiques lors du traitement d'entretien est la garantie pour éviter la réactivation de la symptomatologie

Réponse : **BC**

56) Concernant le traitement de la schizophrénie :

- A- Les antipsychotiques atypiques ont une action sur les symptômes productifs et déficitaires
- B- L'électro convulsivothérapie est indiquée en 1^{ère} intention dans les formes résistantes aux antipsychotiques
- C- Les thérapies cognitivo-comportementales sont les techniques psychothérapeutiques les plus utilisées
- D- En cas de bonne réponse clinique, l'antipsychotique est gardé à la posologie minimale efficace
- E- La dose du traitement doit être adaptée de manière continue en fonction de l'évolution de la symptomatologie et des effets secondaires

Réponse : **ADE**

57) Association thérapeutique dans la schizophrénie :

- A- L'association préventive d'un correcteur anti-cholinergique au traitement antipsychotique est permise chez le sujet âgé
- B- L'association de deux correcteurs anti-cholinergiques n'est pas recommandée du fait de l'augmentation du risque des effets secondaires histaminiques
- C- En début de traitement, l'augmentation posologique de l'antipsychotique est privilégiée à l'association avec une benzodiazépine afin de ne pas multiplier les effets indésirables
- D- L'association électro-convulsivothérapie-clozapine est à éviter même en cas de résistance
- E- L'association de mesures psychothérapeutiques et socio-thérapeutiques aux traitements médicamenteux est fortement recommandé

Réponse : **AE**

58) La clozapine :

- A- Elle constitue une solution thérapeutique face aux réponses partielles à 2 ou 3 antipsychotiques
- B- Elle constitue une solution thérapeutique face à l'intolérance à 2 ou 3 antipsychotiques
- C- Elle donne lieu à des effets secondaires neurologiques minimes
- D- Elle abaisse le seuil épileptogène
- E- Elle expose au risque d'agranulocytose (neutrophiles < 700/mm³)

Réponse : **BD**

59) Le bilan pré-thérapeutique du traitement par antipsychotique doit comprendre :

- A- Évaluation des symptômes psychiatriques
- B- Motivation du patient
- C- Bilan hépatique
- D- Prise de poids
- E- Prise du tour de hanche

Réponse : **ABCD**

60) Le bilan pré-thérapeutique du traitement par antipsychotique doit comprendre :

- A- L'évolution de la maladie
- B- Le contexte socio-familial
- C- Un examen somatique sommaire
- D- Un examen ophtalmologique
- E- Un bilan vitaminique

Réponse : **ABCD**

61) Le bilan pré-thérapeutique du traitement par antipsychotique doit comprendre :

- A- Évaluation de la réponse aux médicaments antérieurement prescrits
- B- EEG
- C- CRP
- D- Bilan lipidique
- E- Glycémie

Réponse : **ABDE**

62) Effets indésirables des antipsychotiques :

- A- Les effets indésirables des antipsychotiques sont liés essentiellement à leur action sur les récepteurs dopaminergiques
- B- Les effets parasympatholytiques se voient surtout avec les antipsychotiques sédatifs
- C- La lipothymie et l'hypotension orthostatique, dues à l'action alpha-bloquante sont plus fréquentes lors de l'association avec des antihypertenseurs
- D- Un syndrome confusionnel lié à un effet anticholinergique périphérique peut apparaître
- E- Un syndrome hyperkinéto-hypertonique peut avoir lieu par blocage des récepteurs dopaminergiques au niveau de la voie nigro-striée

Réponse : **BCE**

63) Concernant les effets indésirables endocriniens et génitaux des antipsychotiques :

- A- Ils sont plus fréquents avec le sulpiride et l'amisulpride
- B- La clozapine, le sertindole, la ziprasidone et la quétiapine induisent peu, ou pas d'hyperprolactinémie
- C- Les menstruations deviennent abondantes
- D- L'hyperprolactinémie chez l'homme entraîne une augmentation de la libido
- E- Une gynécomastie peut apparaître

Réponse : **ABE**

64) Les antipsychotiques peuvent être responsables de :

- A- Asthénie
- B- Manie
- C- Perte de l'affectivité
- D- Obnubilation
- E- État d'indifférence

Réponse : **ACDE**

65) Concernant les effets indésirables métaboliques des antipsychotiques :

- A- La prise de poids se voit après un traitement prolongé
- B- La prise de poids est responsable d'une mauvaise observance
- C- Le rôle diabéto-gène des neuroleptiques est dû à l'induction d'une résistance périphérique à l'insuline associée d'une sécrétion accrue d'insuline
- D- La prise de poids, le diabète et les dyslipidémies augmentent les complications cardiovasculaires
- E- Les butyrophénones donnent très peu de dyslipidémies

Réponse : **BCDE**

66) Les antipsychotiques peuvent être responsables de :

- A- Photosensibilisation
- B- Cécité
- C- Sécheresse de la bouche
- D- Constipation
- E- Iléus paralytique

Réponse : **ABCDE**

67) Concernant les effets indésirables neurologiques des antipsychotiques :

- A- Les dyskinésies aiguës surviennent plus souvent chez le sujet jeune de sexe masculin
- B- Les tasinésies sont très contraignantes et s'aggravent de la poursuite du traitement
- C- Le syndrome pseudo parkinsonien s'atténue progressivement
- D- Les dyskinésies tardives peuvent être irréversibles même après l'arrêt de l'antipsychotique
- E- La clozapine est associée à un risque important de crises d'épilepsie

Réponse : **ACDE**

68) Dyskinésies tardives :

- A- Il s'agit des effets indésirables neurologiques des antipsychotiques les plus fréquentes
- B- Leurs localisations sont oro-faciales, membres et tronc
- C- Leur traitement repose sur les correcteurs antiparkinsoniens
- D- Le switch d'un AP de 1^{ère} génération vers un antipsychotique de 2^{ème} génération peut être utile
- E- Elles peuvent apparaître après une durée d'au moins un mois

Réponse : **BD**

69) Le traitement au long cours par les antipsychotiques peut engendrer, comme effet(s) indésirable(s) :

- A- Syndromes extrapyramidaux
- B- Dyskinésies tardives
- C- Syndrome métabolique
- D- Hypertension artérielle
- E- Prise de poids

Réponse : **ABCE**

70) Le syndrome malin des neuroleptiques peut comporter :

- A- Des variations de la TA
- B- Une bradycardie
- C- Des troubles de la conscience
- D- Une rigidité musculaire sévère
- E- CPK > 1000 U/l

Réponse : **ACDE**

71) Le syndrome malin des neuroleptiques :

- A- Il s'installe habituellement quelques semaines après l'introduction de l'antipsychotique
- B- Il peut aussi survenir lors de l'administration de faibles doses d'antipsychotiques
- C- Il n'est pas induit par les antipsychotiques atypiques
- D- L'hospitalisation dans un service de psychiatrie est obligatoire
- E- La prescription de corticoïdes contribue à l'amélioration rapide du patient

Réponse : **B**

72) La surveillance du traitement par antipsychotiques se fait par :

- A- La recherche d'allongement de l'espace QT est systématique
- B- NFS une fois par mois
- C- Dosage de la prolactine une fois par an
- D- Dosage de la glycémie tous les 6 mois
- E- Bilan lipidique et hépatique une fois par an

Réponse : AE

Cas clinique N°1

Un jeune homme de 17 ans, épileptique et en surpoids, est amené à votre consultation par sa mère.

En effet, depuis quelques jours, il refuse de sortir de sa chambre, se refuse à la moindre activité, ne va plus en classe, a abandonné toutes ses activités de loisir.

Depuis un an et demi, il ne fait plus rien en classe et a redoublé.

Il n'est pas motivé pour faire quoi que ça soit et ne termine aucune action.

Il ne voit plus personne, hormis sa famille.

Il tient des propos étranges, parfois incompréhensibles, prétendant que des extraterrestres ont décidé de l'enlever en raison de ses extraordinaires pouvoirs télépathiques et de son intelligence supérieure.

Il pense avoir pu, jusqu'à présent, leur échapper, mais ceux-ci, dépités croit-il, lui envoient dans le corps des courants électriques et veulent lui arracher les nerfs.

Le patient est angoissé et parle de s'enfuir dans le désert, seul lieu où il peut être vraiment en sécurité.

1- Quel est le diagnostic le plus probable :

- A- Bouffée délirante aigüe
- B- Mélancolie
- C- Dépression névrotique
- D- Schizophrénie
- E- Crise de l'adolescence

Réponse : D

- L'apragmatisme est une incapacité à entreprendre et planifier des actions. Au maximum, le patient peut rester assis ou au lit (clinophilie) à ne rien faire en permanence, jusqu'au point de négliger son hygiène (incurie)
- L'aboulie est une incapacité à mettre en œuvre et maintenir une action, marquée par une diminution de la motivation

2- Quel(s) symptôme(s) relevez-vous :

- A- Délire
- B- Apragmatisme
- C- Impulsion
- D- Aboulie
- E- Tristesse

Réponse : ABD

3- Quel traitement chimiothérapeutique instituerez-vous :

- A- Sels de lithium
- B- Antidépresseurs
- C- Antipsychotiques
- D- Vitaminothérapie
- E- Hypnotiques

Réponse : C

4- Le bilan pré-thérapeutique doit comprendre :

- A- Tests psychométriques
- B- ECG
- C- Bilan rénal
- D- Bilan thyroïdien
- E- Prise de la tension artérielle

Réponse : B

5- Quelle(s) thérapeutique choisir pour ce patient :

- A- Chlorpromazine
- B- Olanzapine
- C- Risperidone
- D- Clozapine
- E- Remédiation cognitive

Réponse : C

Cas clinique N°2

Un homme âgé de 30 ans, est amené par sa famille aux urgences, pour troubles du caractère et du comportement ayant débuté, il y a sept mois, avec une tendance inhabituelle chez lui à avoir des réactions violentes à la moindre contrariété, aggravée depuis cinq semaines par une agressivité verbale envers ses parents, avec rejet de leur proposition de se faire soigner et de prendre des médicaments.

Il a fini par présenter une agitation avec agressivité physique durant les heures précédentes.

À la question de la raison de sa présence aux urgences, il répond qu'il est victime d'un complot élaboré par son entourage familial.

Il n'arrive pas à s'orienter correctement dans le temps et l'espace et déclare souffrir depuis quelques de céphalées gênantes.

1- Quel(s) diagnostic(s) envisagé(s) chez ce patient :

- A- Confusion mentale
- B- Trouble délirant type persécution
- C- Schizophrénie
- D- Tumeur cérébrale
- E- Épilepsie

Réponse : CD

2- Quelle(s) serai(en)t votre conduite pour retenir le diagnostic adéquat :

- A- Traitement antiépileptique d'épreuve
- B- EEG
- C- TDM cérébral
- D- Test psychométrique
- E- Bilan thyroïdien

Réponse : C

Lors de la réalisation de la conduite que vous avez retenue, qui par ailleurs n'a aucune anomalie, le patient s'est agité et a agressé l'infirmier.

3- Concernant le passage à l'acte violent chez ce type de patient :

- A- Il est plus fréquent que dans la population générale
- B- Il se caractérise par son caractère prévisible
- C- Il est généralement étrange et froid
- D- Une psychothérapie de soutien associée à une thérapie permet de juguler la crise
- E- L'ECT constitue la meilleure option thérapeutique

Réponse : C

4- Quelle(s) serai(en)t votre(vos) décision(s) thérapeutique(s) :

- A- Hospitaliser le patient
- B- Prescrire un antipsychotique de 2^{ème} génération en monothérapie
- C- Prescrire un antipsychotique de 1^{ère} génération incisif par voie orale
- D- Prescrire un antipsychotique de 1^{ère} génération sédatif par voie intramusculaire
- E- Prescrire du Modécate pour garantir l'observance

Réponse : AD

Quelques jours après la mise en route du traitement le patient commence à présenter des crises oculogyres et une hypotension.

5- Quelle(s) option(s) thérapeutique(s) envisagez-vous :

- A- Arrêter l'antipsychotique déjà prescrit et passer à un 2^{ème} de 2^{ème} génération
- B- Associer de l'Heptaminol pour corriger l'hypotension
- C- Associer une benzodiazépine pour corriger les crises oculogyres
- D- Associer un traitement anti-cholinergiques pour corriger les crises oculogyres
- E- Attendre, ces symptômes sont des effets secondaires qui s'atténuent avec le temps

Réponse : BD

Cas clinique N°3

Mr A, 28 ans présentant une schizophrénie bien équilibrée sous 4 cp/j de Risperidone, est amené à la salle d'urgence dans un état d'agitation extrême.

Il a été hospitalisé et a bénéficié d'un traitement antipsychotique injectable.

1- La surveillance clinique après l'instauration de ce traitement antipsychotique repose sur :

- A- La diminution du délire
- B- L'apparition de tremblements
- C- L'apparition d'une fièvre
- D- L'apparition d'un goitre
- E- L'apparition d'une hypotension orthostatique

Réponse : ABCE

Quelques jours après son admission, il a présenté une température à 40°C, des modifications tensionnelles et un mutisme.

2- À ce stade de la prise en charge, quelle est votre conduite thérapeutique :

- A- Retenir le diagnostic de syndrome malin des neuroleptiques
- B- Prescrire un antipsychotique désinhibiteur pour juguler le mutisme
- C- Arrêter le traitement antipsychotique
- D- Faire une enquête infectieuse
- E- Prescrire du paracétamol avec des inotropes

Réponse : CD

3- Afin de confirmer le diagnostic de syndrome malin des neuroleptiques, quels autres symptômes doivent être recherchés :

- A- Une élévation des ASAT
- B- Une rigidité musculaire
- C- Une anémie
- D- Une leucocytose
- E- Une élévation des créatinines kinases

Réponse : BDE

4- Une fois le diagnostic confirmé, quelle est votre conduite à tenir :

- A- Hospitalisation en réanimation
- B- Refroidissement jusqu'à 37°C
- C- Réhydratation
- D- Sédation
- E- Prescription de salicylés

Réponse : ACD

Cas clinique N°4

Un jeune homme de 20 ans, apprenti menuisier, est amené aux urgences par sa famille en raison de l'apparition de troubles du comportement avec des bizarreries depuis près d'une année, et qui se sont récemment aggravés par des réactions violentes inattendues.

La consultation en urgence est motivée par son hétéro-agressivité verbale et physique envers son patron au travail.

Lors de l'entretien, il affirme être surveillé par ses collègues au travail par des ondes invisibles télécommandées par son patron.

Ce dernier serait à la tête de ce complot. « C'est lui qui m'empêche d'apprendre le métier. Je suis beaucoup plus intelligent que lui. Il a peur que je le dépasse » dit-il.

Il en est convaincu : les voix le lui ont affirmé. Ce sont elles qui lui ont donné l'ordre de le punir.

Sa famille affirme qu'il n'a rien appris du métier, ne s'est pas intégré au travail, reste tout le temps isolé.

1- Le patient présente :

- A- Un délire de grandeur
- B- Un barrage
- C- Un délire de persécution
- D- Un syndrome d'influence
- E- Des hallucinations

Réponse : ACDE

2- Le diagnostic le plus vraisemblable est :

- A- Un trouble de l'humeur
- B- Une manie délirante
- C- Un délire paranoïaque
- D- Une schizophrénie
- E- Une bouffée délirante aiguë

Réponse : D

3- Les arguments contre le diagnostic de trouble délirant sont :

- A- L'incohérence du délire
- B- Le délire mégalomane
- C- L'âge de début précoce
- D- Présence de bizarreries
- E- La durée d'évolution

Réponse : ACD

4- La prise en charge à court terme comporte :

- A- Anxiolytique
- B- Psychothérapie de soutien
- C- Antipsychotiques
- D- Sels de lithium
- E- L'hospitalisation

Réponse : CE